

1. Accompagnement naturopathique des troubles du système digestif

Objectifs du cours

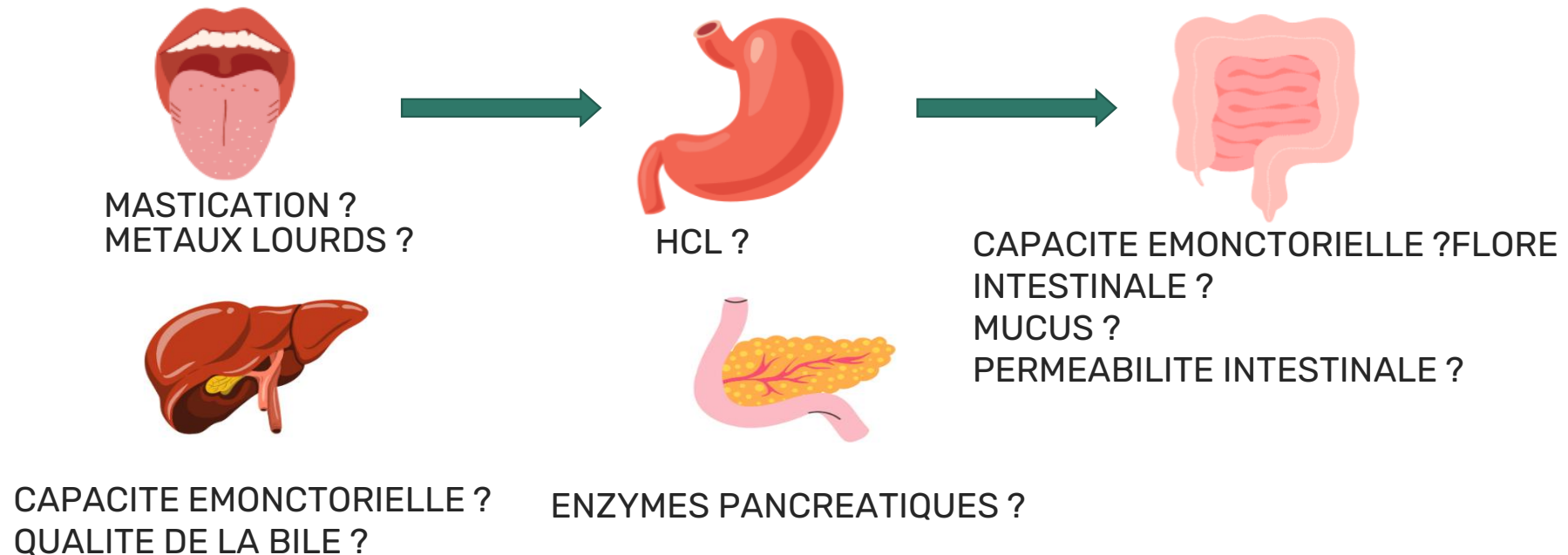
- Décrire et comprendre les pathologies digestives de la bouche jusqu'au pancréas
- Comprendre la complémentarité allopathie / naturopathie
- Apprendre à identifier les déséquilibres de terrain et à en rechercher la ou les causes

- 1 Introduction
- 2 Pathologies de la bouche
 - 1 Inflammations buccales (gingivite, glossite)
 - 2 Candidose buccale
- 3 Pathologies de l'estomac
 - 1 Reflux gastro-oesophagien (RGO), gastrite chronique
 - 2 Hernie hiatale
- 4 Pathologies du foie et de la vésicule biliaire
 - 1 Insuffisance hépatique, surcharge hépatique
 - 2 NASH ou NAFLD
 - 3 Lithiases biliaires
- 5 Pathologies du pancréas
 - 1 Pancréatite

I . Introduction

Pour toutes les pathologies, nous verrons :

- La définition
- Les symptômes
- Le diagnostic "*naturopathique*"
- Les causes possibles
- Les questions à poser en consultation
- Les bilans recommandés
- Les traitements allopathiques
- L'accompagnement naturopathique



II. Pathologies de la bouche

- ✓ Inflammation buccales (gingivite, glossite)
- ✓ Candidose buccale

1. Inflammations buccales (gingivite, glossite)

Rappels d'anatomie-physiologie

Activité enzymatique dans la bouche :

- Au niveau de la langue → **Lipase linguale** → Amorce la digestion des **lipides**
- Au niveau des glandes salivaires → **Amylase salivaire** → Amorce la digestion des **glucides**
- **Composition de la salive :**
- Salive = Eau (97 à 99,5 %) + solutés
- Solutés = ions, enzymes, mucus, déchets, IgA, défensine et lysozyme

Rôles de la langue :

- Participe au goût
- Facilite la mastication
- Mélange les aliments avec la salive et les transforme en une masse compacte
- Participe à la déglutition et à la défense locale
- Permet aussi de prononcer les consonnes.

Flore buccale :

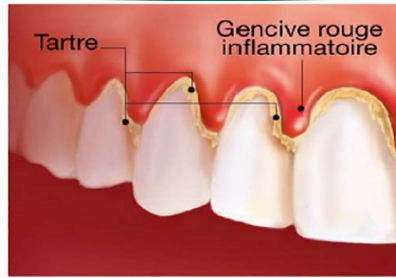
Flore **commensale «amie»** + Flore "**pathogène**" avec bactéries anaérobies, aérobies, champignon, virus notamment le candida albicans et l'HPV.

GLOSSITE



<https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossite>

GINGIVITE



<https://drvibert-dentiste-dechaussement-lyon.com/gingivites/>

CANDIDOSE BUCCALE



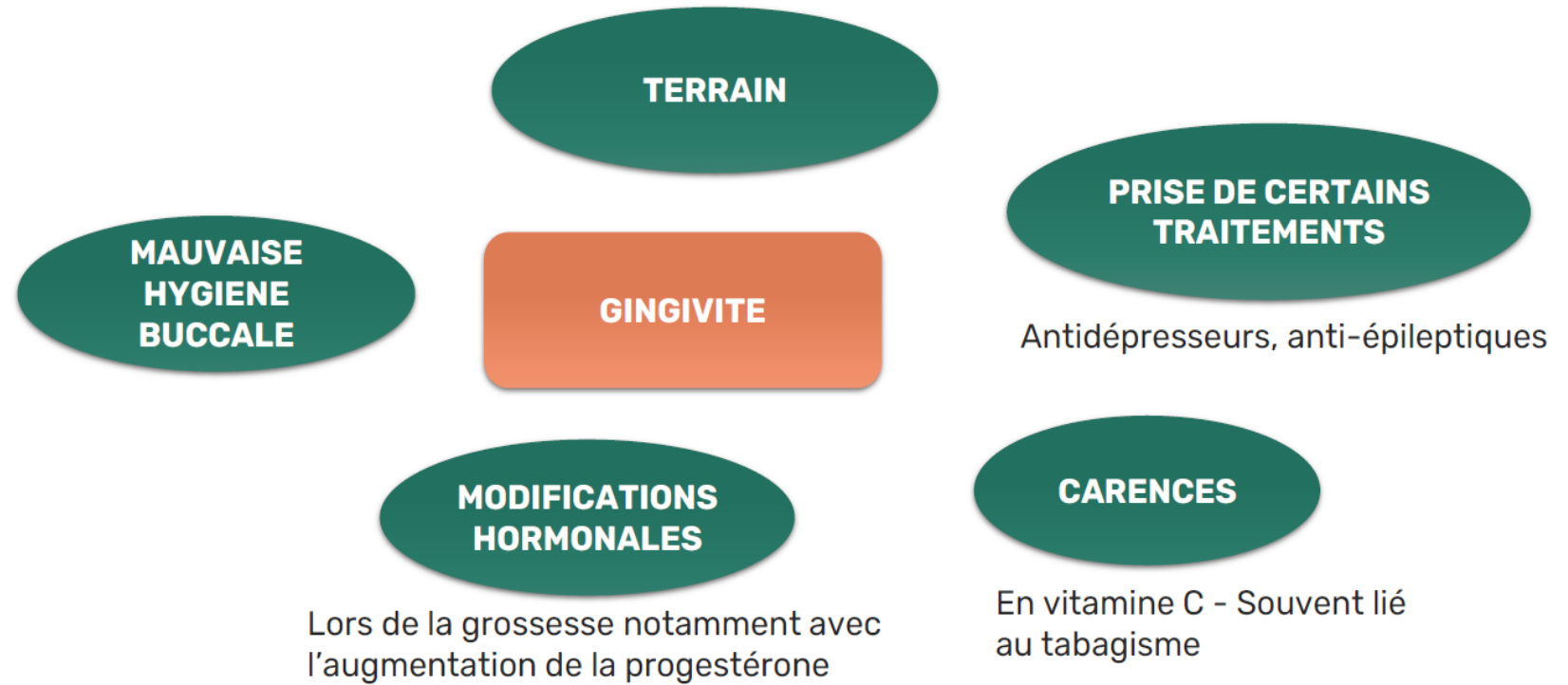
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_buccal

Définitions

	INFLAMMATION BUCCALE		MYCOSE BUCCALE
	Glossite <i>inflammation</i>	Gingivite <i>inflammation</i>	Candidose <i>déséquilibre flore buccale</i>
Définition/ Symptômes	Inflammation de la langue. Langue rouge, décapillée par endroit, parfois fissurée qui peut provoquer des sensations de brûlure à l'ingestion de certains aliments. Porte aussi le nom de langue géographique .	Inflammation des gencives due à une accumulation de la plaque dentaire.	Infection de la langue. Provoquée par un champignon microscopique (Candida albicans le plus souvent) . Se manifeste par un dépôt blanchâtre sur la langue.
Evolution possible / Risques	Directement lié à la cause sous-jacente. Si lié à la maladie de Biermer, risque mortel .	Parodontite = inflammation des tissus de soutien de la dent provoquant une fonte de l'os dans laquelle la dent est implantée → Déchaussement.	Il peut y avoir glossite et candidose buccale en même temps.

Gingivite

- **Causes possibles**



Menez l'enquête - Les questions à poser en séance :

- « *Réalisez-vous régulièrement des détartrages ?* »
- « *Etes-vous la seule personne à avoir des gingivites dans la famille ?* »
- « *Fumez-vous ?* »
- « *Etes-vous sous anti-dépresseurs ou anti-épileptique ?* »
- « *Souffriez-vous de gingivite déjà avant votre grossesse ?* »

Ce que l'on peut proposer en préventif :



En allopathie

En naturopathie



OBJECTIF

Limiter l'accumulation de la plaque dentaire dans le but de prévenir la parodontite

- Brossage des dents régulier (2x par jour)
 - Utilisation de fil dentaire
 - Détartrage (2X par an)
- **Traitement allopathique**
 - Action sur le **terrain** (modulation de l'inflammation)
 - Si **tabagisme** : accompagnement à l'arrêt du tabac, conseils hygiéno-diététiques et **complémentation en vitamine C**

• Ce que l'on peut proposer en curatif

OBJECTIF

Soulager les gencives et limiter les saignements lors du brossage des dents

Aromathérapie	Hydrolathérapie	Autre
Nettoyage de la brosse à dent avec de l' HE de tea tree	Bains de bouche avec de l' HA de laurier noble	Dentifrice à base de propolis (RoyalDent par exemple)

HE = huile essentielle
HA = hydrolathérapie

Glossite

- Causes possibles



Maladie auto-immune entraînant un syndrome sec (*sècheresse...*)

(Ac anti-SSA, anti-SSB)

CHOC
EMOTIONNEL

GLOSSITE

MALADIE DE
BIERMER

Maladie auto-immune entraînant une carence en vitamine B12

(Ac dirigés contre le facteur intrinsèque)
le facteur intrinsèque permet une absorption de la B12

CARENCE

En fer

dosage des anticorps :

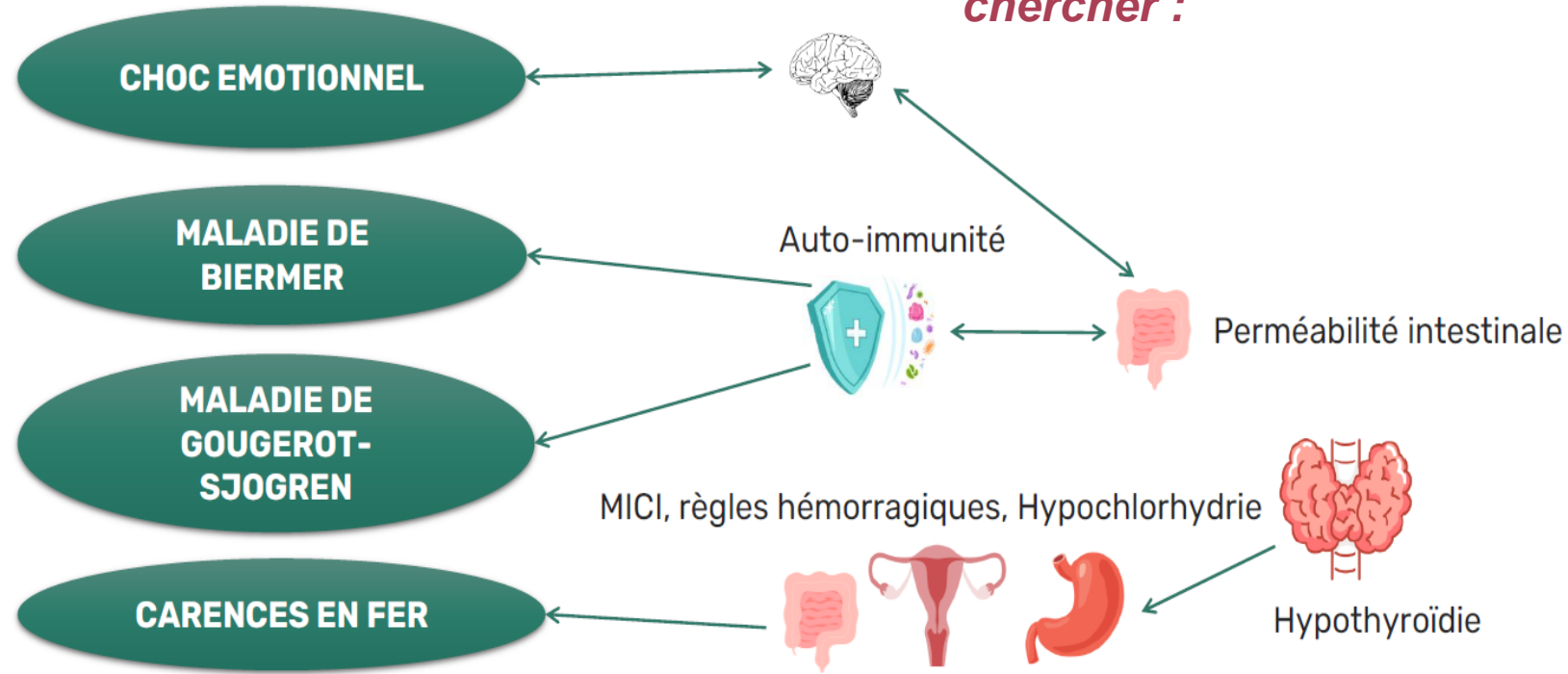
Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation :

- « *Y a-t-il des maladies auto-immunes dans votre famille ?* »
- « *Avez-vous des analyses récentes avec les dosages en ferritine et vitamine B12 ?* »
- « *Un dosage des anticorps anti-SSA, anti-SSB a-t-il été réalisé ?* »
- « *Faites-vous un lien entre l'apparition de votre glossite et un évènement particulier ?* »

Menez l'enquête - Les liens entre les systèmes

1 symptôme = 1 ou plusieurs causes à chercher :

*Reprendre à
24 mn*



Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Le **bilan du statut en acide gras** pour évaluer d'une part l'inflammation avec le rapport AA / EPA et d'autre part la sécheresse des muqueuses avec notamment le taux d'acide palmitoléique
- La **zonuline** pour évaluer la perméabilité intestinale
- Le **typage lymphocytaire TH1 / TH2 / TH17 / Treg** pour évaluer le fonctionnement du système immunitaire

Ce que l'on peut proposer en préventif



En allopathie

OBJECTIF

En naturopathie



Si syndrome de Gougerot-Sjögren : Limiter le syndrome sec

- Corticoïdes, **immunosuppresseurs**, sialagogues augmentant la production de salive (Pilocarpine), collyres

- Modulation de **l'inflammation**
- Modulation du **système immunitaire** avec la phytothérapie : astragale, curcuma, réglisse, sureau (pour augmenter les TReg). **Incompatible avec la prise d'immunosuppresseurs** ⚡
- Renforcement de la **barrière intestinale**
- **Complémentation en Oméga 7** (huile d'argousier)
pr améliorer la sécheresse

Si maladie de Biermer : Maintenir un taux de B12 stable dans le temps pour éviter l'anémie

- **Injection de vitamine B12** par voie intra-musculaire jusqu'à correction de l'anémie puis une fois par mois, à vie. Surveillance de l'estomac par fibroscopie tous les 2 ans.

- **Aucun accompagnement possible. Réservé à l'allopathie**



Si carence en fer : Combler la carence

- **Complémentation en fer :**

Ferrostrane, Tardyferon

Peut parfois causer des désagréments digestifs

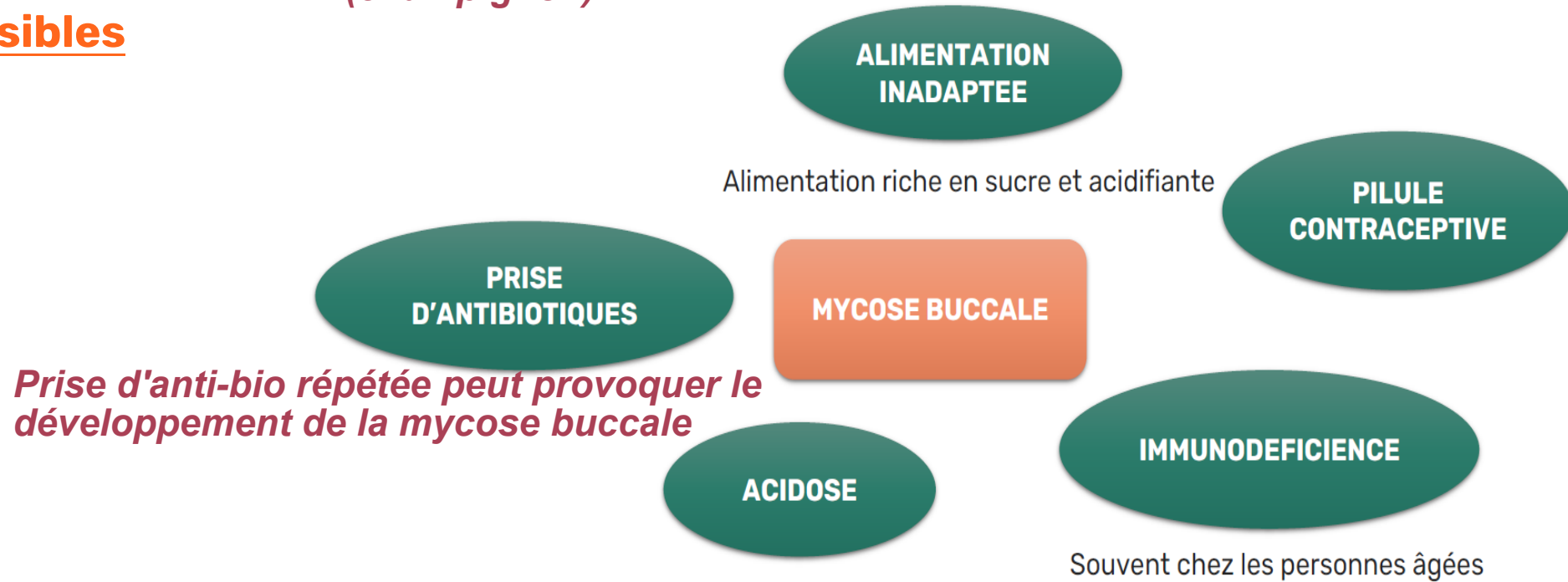
- Complémentation en fer : bisglycinate de fer, picolinate de fer, lactoferrine *toute seule ne sert pas à grd chose à combiner avec bisglycinate de fer.*

Comprendre l'origine de la carence : micro-hémorragies internes liées au port du stérilet, règles hémorragiques, MICI, hypochlorhydrie,...

2. Candidose buccale

Mycose buccale
(*champignon*)

- Causes possibles



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Avez-vous pris des antibiotiques récemment ? »
- « Quel est votre rapport au sucre ? »
- « Etes-vous sous pilule contraceptive ? »
- « Souffrez-vous de mycoses vaginales, unguéales ? »

Partez à la recherche d'éventuels signes d'acidification de l'organisme arthrose, calculs rénaux, eczéma sec, psoriasis,...

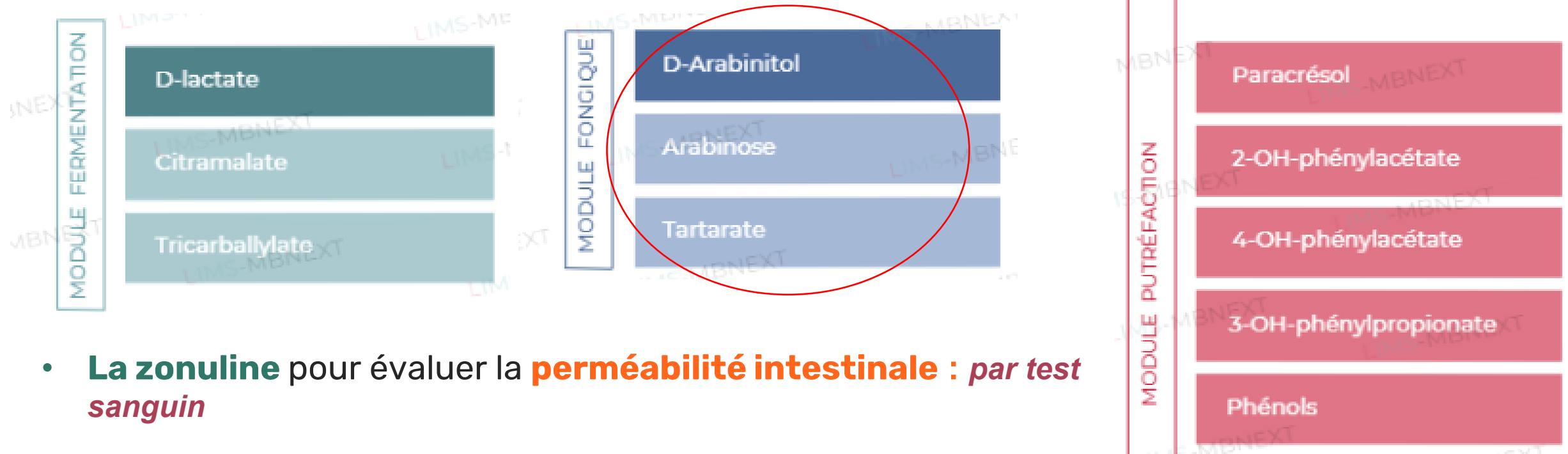
Partez à la recherche d'éventuels troubles digestifs pour faire un lien éventuel avec une mycose digestive.

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

Si troubles digestifs :

- **Microbiote intestinal et en particulier métabolites fongiques**

Analyse urinaire (métabolite urinaire) ci-dessous : pour savoir si candidose digestive ou non lorsqu'il n'y pas de signe visible de la mycose buccale



- **La zonuline** pour évaluer la **perméabilité intestinale** : *par test sanguin*

<https://lims-mbnext.eu/bilans-dinvestigation-preventive/dysbiose-mycose-intestinale/>

Ce que l'on peut proposer en préventif



En allopathie

Eradiquer localement le champignon

- **Bains de bouche antiseptiques**
- Antifongique local (Gel ou pastilles) contenant des antifongiques comme la **nystatine, l'amphotéricine ou le miconazole**
- Antifongique par voie orale : **kétoconazole ou fluconazole**

Risque important de rechute

OBJECTIF

En naturopathie



Eviter les récurrences en rééquilibrant le terrain (action sur l'hygiène de vie et les facteurs favorisants)

- **Si lié à une prise d'antibiotiques**, traiter la candidose au niveau digestif
- **Si lié à une prise de pilule contraceptive**, trouver une alternative n'entraînant pas de modification hormonale (préservatif, symptothermie)
- **Si alimentation inadaptée ou acidose**, corriger l'alimentation. Aller vers une alimentation antifongique, alcalinisante et pauvre en sucre...

- **Comment corriger l'acidose avec l'alimentation ?** *Vocabulaire naturopathique à retenir*

Aliments favorisant la candidose =

Aliments acidifiants + Aliments riches en sucre + Aliments fermentés (Choucroute, Kéfir, Kombutcha, produits lactofermentés) + **champignons + fromages à moisissures + pomme de terre**

Aliments freinant la candidose =

Aliments alcalinisant + Aliments antifongiques (ail, noix de coco, huile de coco, Lapacho)

- # Les aliments alcalinisants et acidifiants

<https://dynamic-seniors.eu/acidose-conseils-alimentaires/>

Groupes d'aliments	Alcalinisants			Acidifiants		
	Tres	Moyen	Peu	Peu	Moyen	Tres
Fruits	Mûre, Fraise, Framboise, Melon d'eau, Agrumes,	Raisin, Abri-cot, Pomme, Avocat, Banane	Noix de coco	Figue, Datte, Tomate Prune	Canneberge, Grenade	
Légumes	Asperge, Céleri, Légumes verts feuillus, Endive, Chou Frisé, Patate douce	Artichaut, Pomme de terre, Betterave, Brocolis, Chou	Pois mange-tout, Carotte, Concombre, Chou de Bruxelles, Chou-fleur	Pois vert, Pois cassé, Epinard, Poireau, Oignon Échalote		
Viandes, volailles et poissons				Palourde	Saumon, La-pin, Poulet, Foie, Bison, Agneau	Saucisse, Crevette, Homard, Bacon, Hamburger, Steak
Produits laitiers, œufs			Beurre clarifié, Œuf (jaune)	Beurre, Fromage caillé	Fromage cottage, Œuf (blanc)	Camembert, Cheddar, Yogourt
Huiles			Olive, Coco, Foie de Morue, Avocat	Sésame, Canola, Tournesol	Soja	

- # Ce que l'on peut proposer en curatif

OBJECTIF

Rééquilibrer la flore buccale

Groupes d'aliments	Alcalinisants			Acidifiants		
	Tres	Moyen	Peu	Peu	Moyen	Tres
Huiles			Olive, Coco, Foie de Morue, Avocat	Sésame, Canola, Tournesol	Soja	
Noix, graines, légumineuses, épices	Châtaigne, Gingembre, Graine de citrouille, Sel de mer	Poivre noir, Noix de cajou, Ail, Cannelle, Sauce soja	Tournesol, Sésame, Lin, Aman-de, Noix de macadamia	Fève cuite, Haricots rouges et blancs, Pois chiche	Arachide	Noix, Hari-cot de soja, Sel de table iodé, Sucre blanc
Pains, céréales, desserts			Gruau, Crousta-de aux pommes & sucre brut, quinoa	Riz brun, Farine de Sarrasin	Pain de blé entier, Pain de seigle, Tortillas de maïs, Semoule de maïs, Tarte aux fruits maison	Croissant, Bagel, Gâteau au chocolat, Craquelin Salé, Tarte aux fruits industrielle
Aliments préparés ou restauration rapide				Mayonnaise	Maïs soufflé, Ketchup, Moutarde	Croustille, Pizza, Sandwich au bœuf, Tacos, Nuggets
Boissons	Eau minérale, Thé au gingembre	Jus de pamplemousse, Jus d'ananas	Jus de pomme, jus de raisin, jus d'orange, Thé vert	Lait, Kéfir, Thé noir, Jus de tomate	Vin, Bière brune, Café, Boisson de riz	Bière blonde, Café expresso, Boissons gazeuses, Boissons de soja

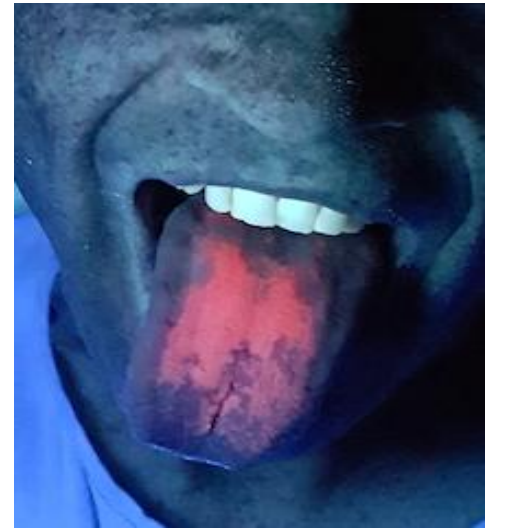
Complémentation	Autre
Probiotiques Pileje Lactibiane Buccodental	Nettoyer la langue avec un gratte-langue ou des bains de bouche à l'huile de coco

Technique d'analyse de la langue

- Possibilité d'analyser la langue avec la **lampe de Wood** pour en savoir plus sur la flore buccale (cf. travaux du Dr DONATINI).

Vidéo Youtube : « La bouche, miroir de votre santé »

- Il est **important** aussi de **demander au consultant** s'il a des amalgames dentaires afin de faire des liens avec les symptômes évoqués et les métaux lourds. Orienter si besoin vers un **dentiste holistique**.



<https://www.chrononutrition.ch/analyse-des-gaz-expir%C3%A9s/la-lampe-de-wood/>

III. Pathologies de l'estomac

1. Reflux gastro-oesophagien (RGO), gastrite chronique

<https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/estomac/>

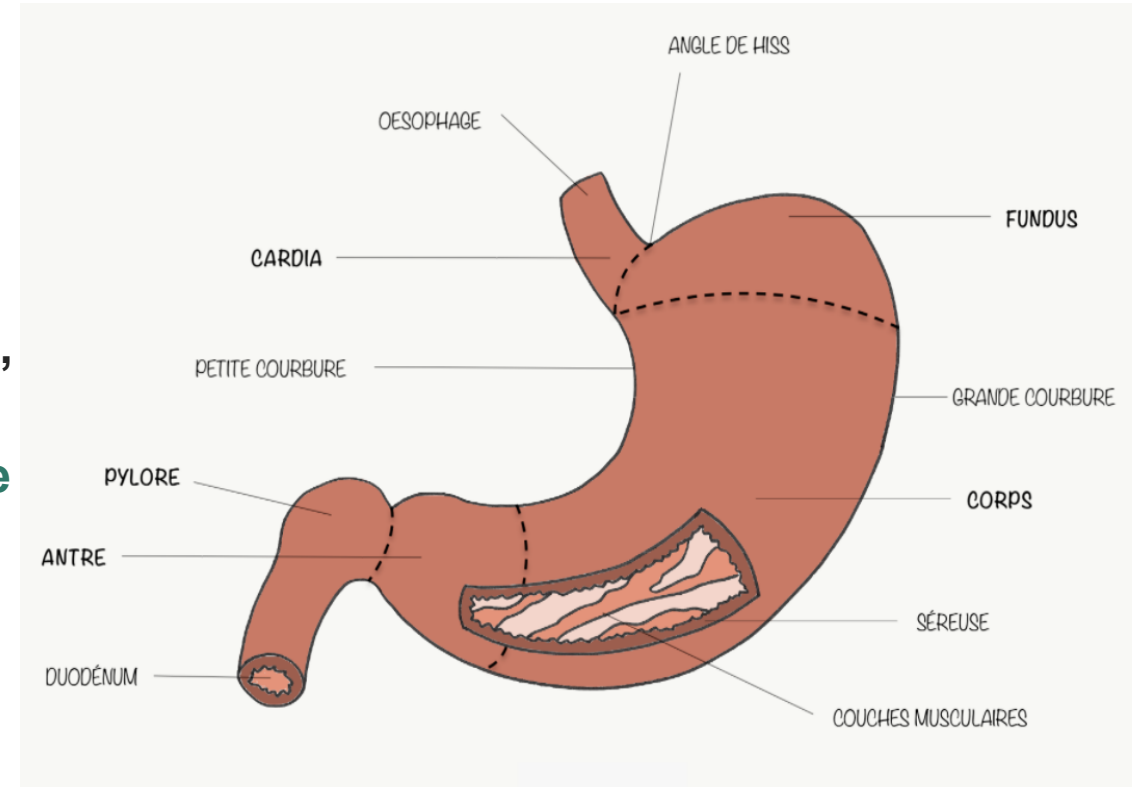
Rappels d'anatomie-physiologie

- L'estomac fait suite à la bouche puis l'œsophage.
- Au niveau de l'estomac, les aliments poursuivent leur dégradation grâce à la **digestion chimique** et la **digestion mécanique**.
- Durant la **digestion chimique**, les **aliments sont broyés, malaxés et brassés**.
- Lors de la digestion chimique, le **pepsinogène est transformé en pepsine sous l'action de l'HCL** permettant d'entamer le processus de **digestion des protéines**.

Diverses sécrétions ont lieu au niveau de l'estomac :

- **Sécrétion de mucus** : Permet de protéger la muqueuse gastrique
- **Sécrétion d'HCl** : L'HCl a une fonction bactéricide

- **Sécrétion du facteur intrinsèque** : Permet l'absorption de la vitamine B12
- **Sécrétion de gastrine** : Permet la **régulation de la sécrétion acide**



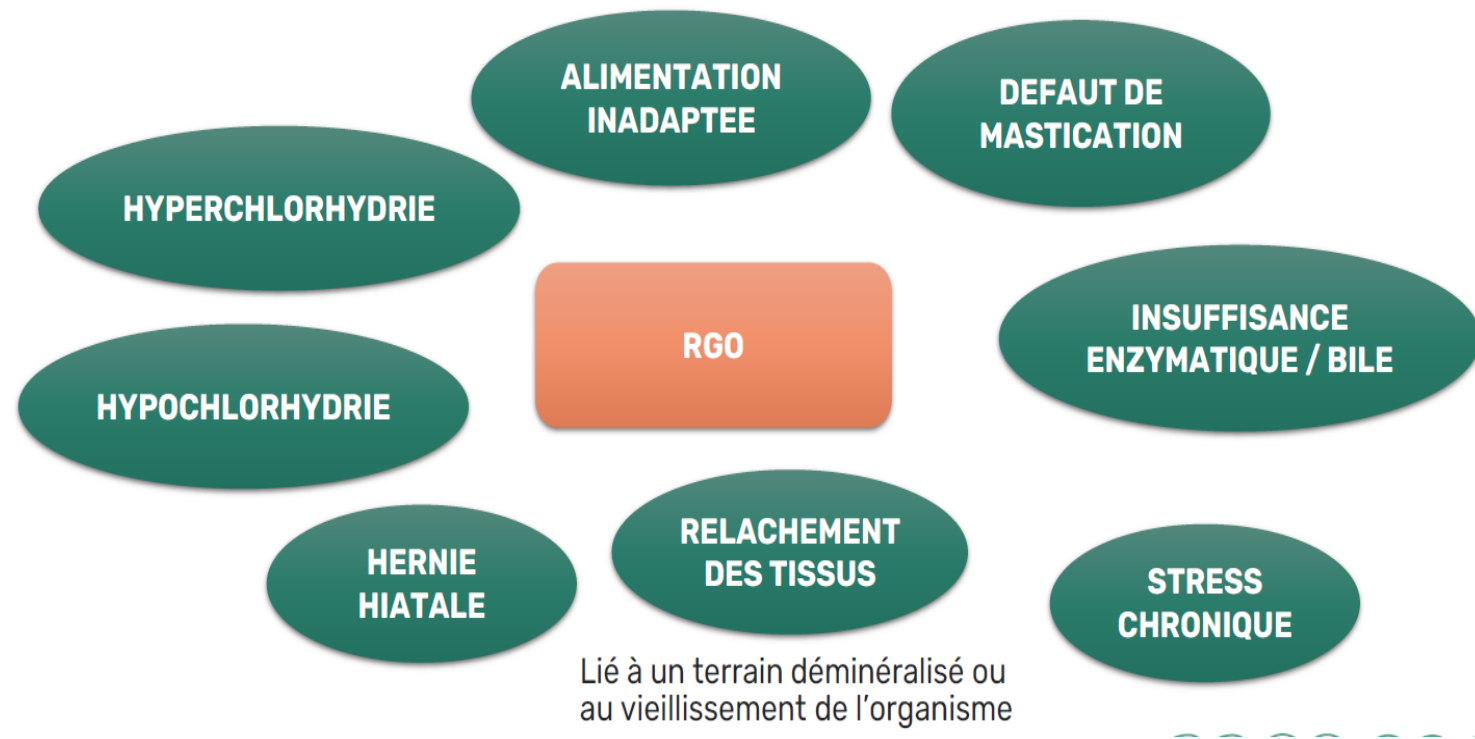
Substances sécrétées par l'estomac et fonctions dans la digestion chimique

digestion chimique			fonction
hormones	enzymes	autres	
Cellules G → gastrine	<i>stimule les glandes gastriques pour produire</i> Cellules principales → lipase gastrique → proenzyme pepsinogène ↓ enzyme pepsine (active)	Cellules caliciformes → mucus visqueux et alcalin Cellules pariétales ou bordantes : → facteur intrinsèque → HCl ← active	- nourriture dans la bouche et PH acide de l'estomac => production de gastrine stimulant les glandes gastriques pour produire : - pepsinogène (précurseur de la pepsine) - mucus (protection des parois de l'estomac) - HCl (déstructuration des protéines, protection/bactéries) pepsine : protéase, amorce la digestion des protéines → peptides (<50 AA) lipase gastrique : rôle majeur pour le nouveau-né dont l'alimentation est particulièrement riche en lipides (lait) facteur intrinsèque : permet l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle suc gastrique : ensemble des sécrétions (1,5 à 2 l/jour)

Définitions

	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN (RGO)	GASTRITE CHRONIQUE	HERNIE HIATALE
Définition / Symptômes	Régurgitation du contenu acide de l'estomac dans l'oesophage. Sensation de brûlure au creux de l'estomac irradiant derrière le sternum. La douleur survient souvent après les repas.	Inflammation de la muqueuse de l'estomac.	Poche formée par la partie supérieure de la grande courbure de l'estomac qui passe par le trou œsophagique du diaphragme (hiatus œsophagien). Asymptomatique ou RGO entraînant brûlures œsophagiennes, remontées acides, douleurs à l'abdomen, régurgitations alimentaires, éructations, hoquet, nausées, toux.
Evolution possible / Risques	Œsophagite peitque avec risque d'endobrachyoesophage.	Douleurs gastriques (brûlures d'estomac) déclenchées ou exacerbées par la prise de certains aliments .	Oesophagite et sténose de l'oesophage, cancer de l'œsophage.
<i>Diagnostic</i>	Sur la clinique et fibroscopie si besoin.	Sur la clinique et fibroscopie si besoin.	<i>fibroscopie + radiographie pulmonaire</i>

Causes possibles

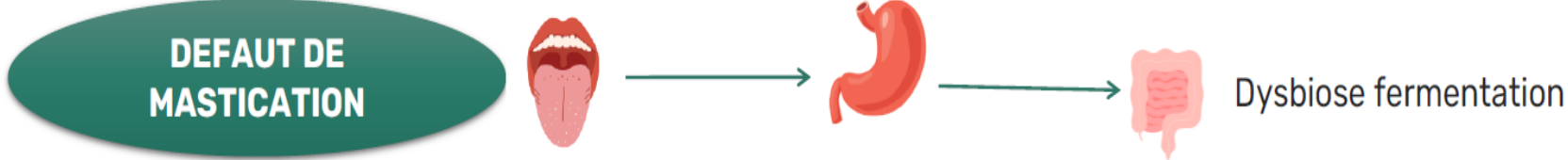


Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

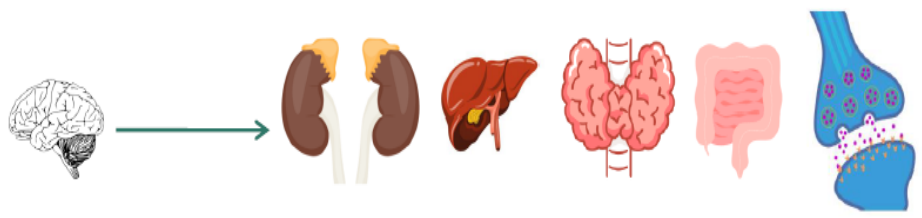
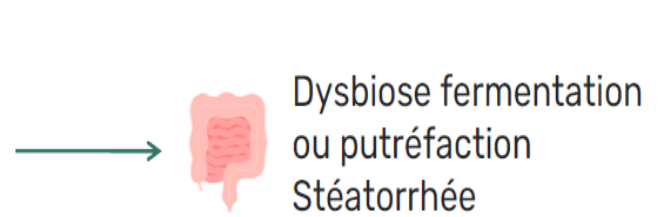
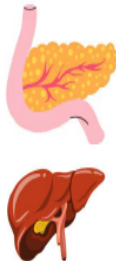
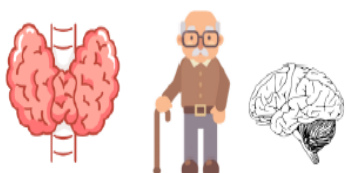
- **« Prenez-vous le temps de manger ? »**
- **« Faites-vous un lien entre vos symptômes et une situation de stress ? »**
- **« Avez-vous des sensations de brûlure dans l'estomac ou uniquement du reflux ? »**
- **« Avez-vous réalisé une fibroscopie ? »**
- **« Votre médecin vous a-t-il prescrit un traitement pour votre reflux (IPP) ? »**
- **« Vos symptômes se déclenche-t-il avec des aliments spécifiques ?(FODMAPS, aliments irritants comme le piment, l'alcool, le café) »**
- **« Le reflux survient-il plutôt avant ou après le repas ? »**

**Menez l'enquête -
Les liens entre les systèmes**

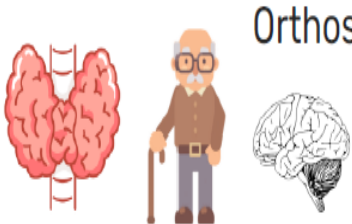
*les fleches sont à
l'envers, il faut lire la
slide de les dysbioses*



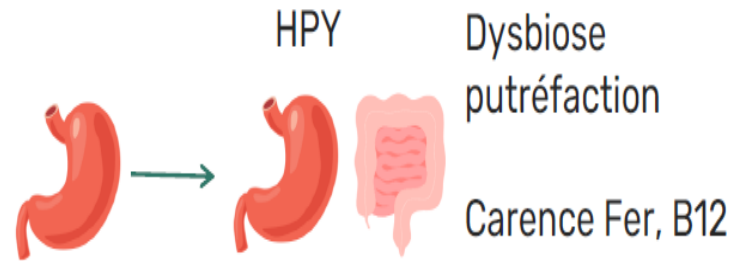
Hypothyroïdie, âge, orthosympathique ++



HLC est bactéricide



Orthosympathique ++



Parasympathique ++ *(crispation interne)
en hyper fonctionnement*



Menez l'enquête- Les bilans spécialisés recommandés

<https://lims-mbnext.eu/bilans-dinvestigation-preventive/polymorphisme-fut2/>
<https://lims-mbnext.eu/bilans-dinvestigation-preventive/acides-biliaires/>

- Le **FUT-2** pour évaluer la qualité du **mucus**
- Les **acides biliaires** pour évaluer la qualité de la bile

Ce que l'allopathie propose :



En allopathie

OBJECTIF

Soulager les brûlure épigastriques en abaissant l'acidité de l'estomac et en protégeant la muqueuse gastrique

- **1^{ère} intention** : Conseils hygiénodietétiques + **Pansements gastriques (Gaviscon)**
- **2^{ème} intention** : **Médicaments anti-acides** (IPP = inhibiteurs de la pompe à protons)
- **Exemples d'IPP** : Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole
- **En cas d'échec du traitement** : technique chirurgicale consistant à créer une valve anti-reflux entre œsophage et estomac

Ce que l'allopathie propose :



En allopathie

Soulager les brûlure épigastriques en abaissant l'acidité de l'estomac et en protégeant la muqueuse gastrique

- **1^{ère} intention** : Conseils hygiénodietétiques + **Pansements gastriques (Gaviscon)**
- **2^{ème} intention** : **Médicaments anti-acides** (IPP = inhibiteurs de la pompe à protons)
- **Exemples d'IPP** : Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole
- **En cas d'échec du traitement** : technique chirurgicale consistant à créer une valve anti-reflux entre œsophage et estomac

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :



OBJECTIF GENERAL :

Comprendre l'**origine du RGO** et rééquilibrer le **terrain** en **corrigant les erreurs d'hygiène de vie** et en **soutenant la digestion**

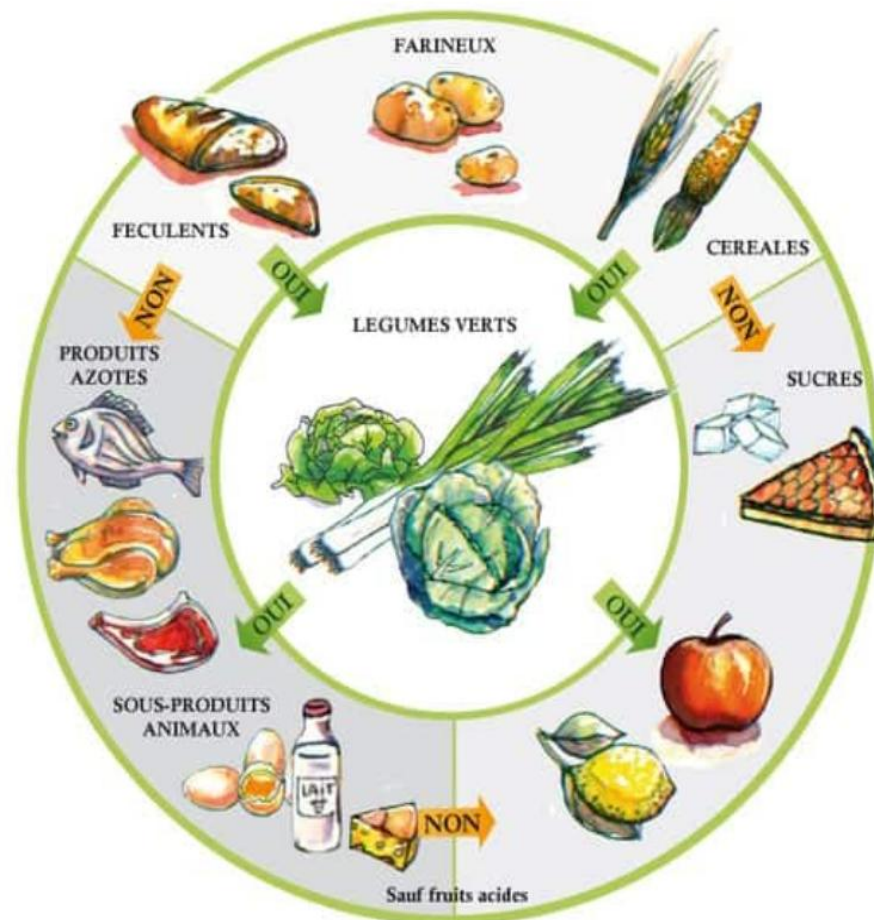
- Si l'alimentation est inadaptée et la mastication insuffisante

SOUS-OBJECTIF : Corriger l'alimentation et améliorer la digestion

- **Alimentation dissociée et/ou pauvre en FODMAPS** en fonction des symptômes évoqués par le consultant
- Manger **lentement** et **à distance du coucher**
- Surélever **la tête avec un oreiller le soir**

	Pauvre en FODMAP	Riche en FODMAP
Viande, volaille, poisson, œufs	Bœuf, poulet, thon en conserve, œufs, poisson, agneau, porc, crustacés, dinde, viande froide	Plats cuisinés avec des ingrédients riches en FODMAP ou en sirop de maïs à haute teneur en fructose
Laitages	Lait et yaourts sans lactose, beurre, fromages à pâte dure, brie, camembert	Lait de vache, de brebis, de chèvre. yaourts, crème anglaise, crèmes glacées, fromage blanc... Chocolat, fromages à pâte molle
Céréales	Avoine, épeautre, riz, tapioca, quinoa, maïs	Produits à base de blé et de seigle
Fruits	Banane, baies, raisin, kiwi, fraise, kumquat, citron, mandarine, clémentine, orange, fruit de la passion, ananas, rhubarbe, melon	Pomme, abricot, date, cerise, framboise, goyave, lychee, mangue, nectarine, pêche, poire, figue, prune, kaki, pastèque, fruits en conserve, fruits secs,
Légumes	Poivron, aubergine, concombre, carotte, céleris, maïs, laitue, haricot vert, pomme de terre, tomate, courgette, olive	Artichaut, avocat, asperge, betterave, poireau, brocoli, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, fenouil, céleri, champignon, pois mange tout,
Boissons	Café, thé, jus de fruits pauvres en FODMAP	Boissons à base de sirop de maïs à haute teneur en fructose, jus de fruits riches en FODMAP, vins fortifiés (sherry, marsala..)
Assaisonnements et condiments	La plupart des épices et herbes, bouillon fait maison, ciboulette, ail, huile d'olive, vinaigre, vinaigre balsamique, poivre, sel, sucre	Ail, oignons, miel, confiture, gelée, cacao en poudre, produits à base de légumes ou fruits à haute teneur en FODMAP, chutneys, édulcorants artificiels : sorbitol, mannitol, isomalt, xylitol inuline
Noix et graines	Amande (en petite quantité), graine de potiron	Noix de cajou, pistache,

LES BONNES COMBINAISONS ALIMENTAIRES



- Si le consultant exprime un lien direct entre son RGO et des situations de stress

SOUS-OBJECTIF : Limiter le stress

Proposer des techniques de gestion du stress.

- Si le consultant a des signes de déminéralisation

SOUS-OBJECTIF : Reminéraliser

Proposer des aliments **riches en minéraux** : algues, cru, herbes aromatiques, plasma de Quinton.

- **Comment évaluer si le consultant est en hypochlorhydrie ou hyperchlorhydrie ?**

Faire le test du **bicarbonate de soude**

Faire le test au lever, l'estomac vide.

Dissoudre 1/4 de c-à-café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau ;

Boire et démarrer un chronomètre ;

Arrêter à la première éructation et noter le temps écoulé.



Bicarbonate + HCL (estomac) = CO2

Au plus on a d'HCL, plus l'éructation est puissante et arrive rapidement.

Avant 1 min : **Hyperchlorhydrie**

Entre 1 et 2 min : Pas de déséquilibre

Après 2 min : **Hypochlorhydrie probable**

Après 5 min : **Hypochlorhydrie quasi certaine**

- Si le consultant est en hypochlorhydrie (fréquent) : le consultant a souvent des douleurs après les repas dans ce cas-là.

SOUS-OBJECTIF : Comprendre l'origine de l'hypochlorhydrie et augmenter la sécrétion d'HCl

- Si le consultant est sous IPP, lui expliquer que les IPP vont favoriser son hypochlorhydrie mais ne pas lui dire de les arrêter pour autant. Lui proposer des analyses pour comprendre pourquoi il est hypochlorhydrie et ce que cela implique sur sa digestion.
- Boire le moins possible durant les repas pour ne pas diluer les **sécrétions gastriques**.
- S'il n'est pas sous IPP, Proposer un complément d'HCl.

 **Contre-indiqué en cas d'ulcère gastrique.**



- Si le consultant est en hyperchlorhydrie (plus rare) : Le consultant a souvent des douleurs avant les repas dans ce cas-là.

SOUS- OBJECTIF : Comprendre l'origine de l'hyperchlorhydrie et diminuer la production d'HCl et protéger la muqueuse gastrique

- Les **IPP** sont fortement recommandés ou en alternative le **bourgeon de figuier** (draineur estomac, régulateur HCl, cicatrisant).
- **Argile** par voie orale. **Attention, peut provoquer de la constipation.**
- Jus de pomme de terre crue.
- **Jus d'aloë vera** par voie orale entre les repas.



- **Comment évaluer si le consultant manque d'enzymes digestives ?**

Si la prise **d'enzymes digestives** provoque un mieux-être ou par une analyse du type **Coproscreen** mais c'est une analyse assez coûteuse.

Trop cher pour les infos que l'analyse apporte, à nous de plutôt réfléchir pour savoir quoi faire (enzymes digestives...)

CONCLUSION DE L'EXAMEN PHYSIQUE DES SELLES

Fonctions motrices :

Le transit paraît être alterne : alternance de périodes où le transit est sensiblement accéléré (avec ou sans diarrhée) avec des périodes où le transit est plus ralenti (avec ou sans constipation).

Troubles vaso-sympathique probable de la motilité intestinale.

Fonction gastrique :

La digestion reste limitée.

Une mastication suffisante et efficace permettrait de limiter ces phénomènes.

Fonction hépatobiliaire :

La digestion reste correcte.

Fonction pancréatique lipidique :

La digestion reste limitée. L'origine ou les origines des anomalies biologiques retrouvées peut ou peuvent être diverses et multiples et doit ou doivent être recherchée(s) en fonction de la clinique et des prises médicamenteuses du patient : – Insuffisance de sécrétions en lipase pancréatique. – Excès d'apports alimentaires en acides gras saturés et/ou polyinsaturés. – Médications grasses (laxatifs,...). A corrélérer à la clinique.

Fonction pancréatique protéique :

La digestion reste limitée. L'origine ou les origines des anomalies biologiques retrouvées peut ou peuvent être diverses et multiples et doit ou doivent être recherchée(s) en fonction de la clinique et des prises médicamenteuses du patient : – Vidange gastrique un peu rapide.

– Défaut de mastication. – Insuffisance en trypsine pancréatique. A corrélérer à la clinique.

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :

- Si le consultant est en insuffisance enzymatique ou biliaire :

SOUS-OBJECTIF : Relancer la fonction pancréatique et biliaire dans le but de soutenir la digestion

- Plantes amères (gentiane, l'artichaut ou le radis noir) pour **augmenter les sécrétions de sucs digestifs**
- Complémentation en **enzymes digestives**



Ingrédients par comprimé	
HCl de bétaine	155 mg
Pepsine	315 FCC
Pancréatine (mélange d'amylase 9600 USP, lipase 800 USP, et Protéase 9600 USP)	
Acide L-Glutamique HCl	100 mg
Lipase	7500 FCC
Papaine	22,5 FIP
Amylase	990 FCC
Bromelaïne	120 FIP

Papaine et bromelaïne pr la digestion des protéines

Bromélaïne extraite de tige d'ananas *Ananas comosus* (L.) Merrill,
complexe d'enzymes digestives : **amylase***, **phytase**,
lactase, **lipase***, **protéase***, **cellulase**, **diastase**,
enveloppe de la gélule végétale : pullulan,
Tolerase-G® : **prolyl-oligopeptidase**,
sels calciques de l'acide citrique.
**issues de champignon*
Tolerase-G® est une marque commerciale de DSM.



Ingrédients
- Extrait sec d'orge, malt (*Hordeum vulgare*) - (Belgique)
- Cellulase (*Aspergillus niger*) - (non UE)
- Lactase (*Aspergillus Oryzae*) - (non UE)
- Lipase (*Thermomyces lanuginosus*) - (non UE)
Enveloppe de la gélule d'origine végétale :
Hydroxypropylméthylcellulose
Garanti sans gluten

Composition nutritionnelle pour 3 gélules
Extractions intégrales* aqueuses issues de
- Orge, sans gluten 1050 mg dont :
• Amylase 840 mg
• Phytase 105 mg
• Protéase 105 mg
- Cellulase 150 mg
- Lactase 150 mg
- Lipase 150 mg

2. Hernie hiatale

<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2513846-hernie-hiatale-glissement-roulement-symptome-cause-traitement-operation/>

Cause inconnue mais **l'obésité** est un facteur favorisant. Le RGO est une conséquence fréquente de la hernie hiatale.

Ce que l'on propose :



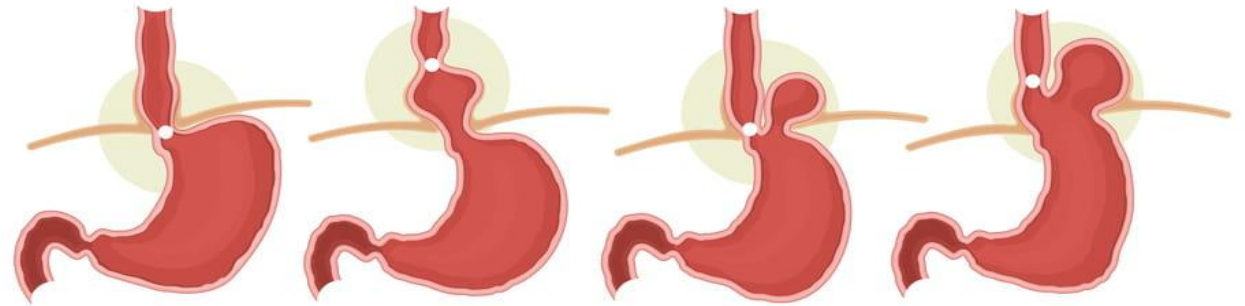
En allopathie

OBJECTIF

Si RGO, soulager les brûlures épigastriques en diminuant l'acidité gastrique

- Voir accompagnement du RGO en allopathie
- Intervention chirurgicale si le RGO est trop important

TYPES DE HERNIES HIATALES



Oesophage et estomac normaux

Type 1
Hernie hiatale par glissement

Type 2
Hernie hiatale par roulement

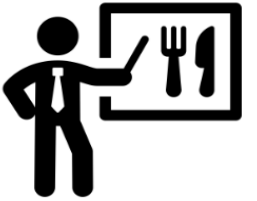
Type 3
Hernie hiatale mixte

En naturopathie

OBJECTIF

Si RGO, soulager les douleurs épigastriques en corrigeant les erreurs d'hygiène de vie et soutenant la digestion

- Voir accompagnement du RGO en naturopathie



Gastrite chronique

- **Causes possibles**

AGENTS IRRITANTS

Tabac, alcool, épices, chocolat

HELICOBACTER PYLORI (HPY)

Bactérie présente dans l'estomac

Gastrite chronique

CERTAINS TRAITEMENTS

AINS, bêta-bloquant

Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation :

Même questions que pour le RGO et en plus :

- « *Votre médecin vous a-t-il prescrit une analyse pour évaluer la présence de l'HPY ?* »

Comment évalue-t-on la présence d'HPY ?

Fibroscopie

ou moins invasif : prise de sang, recherche d'antigènes dans les selles, test respiratoire.

Ce que l'allopathie propose :



En allopathie

OBJECTIF

Soulager les brûlures gastriques en abaissant l'acidité de l'estomac et en protégeant la muqueuse gastrique

- 1^{ère} intention : Conseils hygiénodietétiques + **Pansements gastriques (Gaviscon)**.
- 2^{ème} intention : **Médicaments anti-acides** (IPP = inhibiteurs de la pompe à protons).
- Exemples d'IPP : Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole.
- En cas d'HPY : **Antibiotiques + IPP.** *même traitement que pr le RGO et en + antibiotiques et IPP*

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :



OBJECTIF GENERAL

Comprendre l'origine de la gastrite, corriger les erreurs d'hygiène de vie, soutenir la digestion

- **Si le consultant consomme des agents irritants** : l'accompagnement à l'arrêt du tabac et / ou de l'alcool (recommandation hypnose, acupuncture, kudzu,...) et des **aliments irritants** pour la muqueuse gastrique (épices, chocolat,...)
- **Si le consultant exprime un lien direct entre ses douleurs gastriques et des situations de stress** : proposer des **techniques de gestion du stress**

- Si l'HPY est présent :

SOUS-OBJECTIF : Eradiquer l'HPY

Consommation d'aliments riches en sulforaphanes comme le brocoli et le radis noir par ex.

Probiotiques spécifiques contenant de la réglisse : Pileje Lactibiane H-Py.

⊘ **Contre-indiqué en cas d'hypertension**

Bien expliquer au consultant que les HE sont beaucoup moins efficaces que les antibiotiques.

Proposer une prise d'huiles essentielles anti-bactériennes par voie orale : A faire faire à la pharmacie homéopathique de l'Europe. *Les HE à utiliser avec parcimonie si la personne ne veut pas prendre les antibiotiques du médecin*

Formule A :

- HE lentisque pistachier 20 mg
- HE Sarriette 10 mg
- HE Thym à linalol 10 mg
- Excipient qsp 1 gélule n°30

2 gélules matin + 2 gélules soir au cours des repas avec un peu d'huile d'olive pendant 7 jours.

Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy

Tout de suite après :

Formule B :

- HE Ravintsara 20 mg
- HE Niaouli 10 mg
- HE Menthe poivrée 10 mg
- HE Lavande aspic 10 mg
- HE Citron 10 mg
- Excipient qsp 1 gélule n° 30

3 gélules par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) au cours des repas avec un peu d'huile d'olive pendant 10 jours.

A prendre au cours des repas avec un peu d'huile d'olive.

Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy

IV. Pathologies du foie

- ✓ Insuffisance hépatique
 - ✓ NASH ou NAFLD
 - ✓ Lithiases biliaires

1. Insuffisance hépatique, surcharge hépatique

Rappels d'anatomie-physiologie

Rôles du foie :

- **Métabolisme**

Glucides, lipides (cholestérol, vit D), protéines (albumine)

- **Epuration**

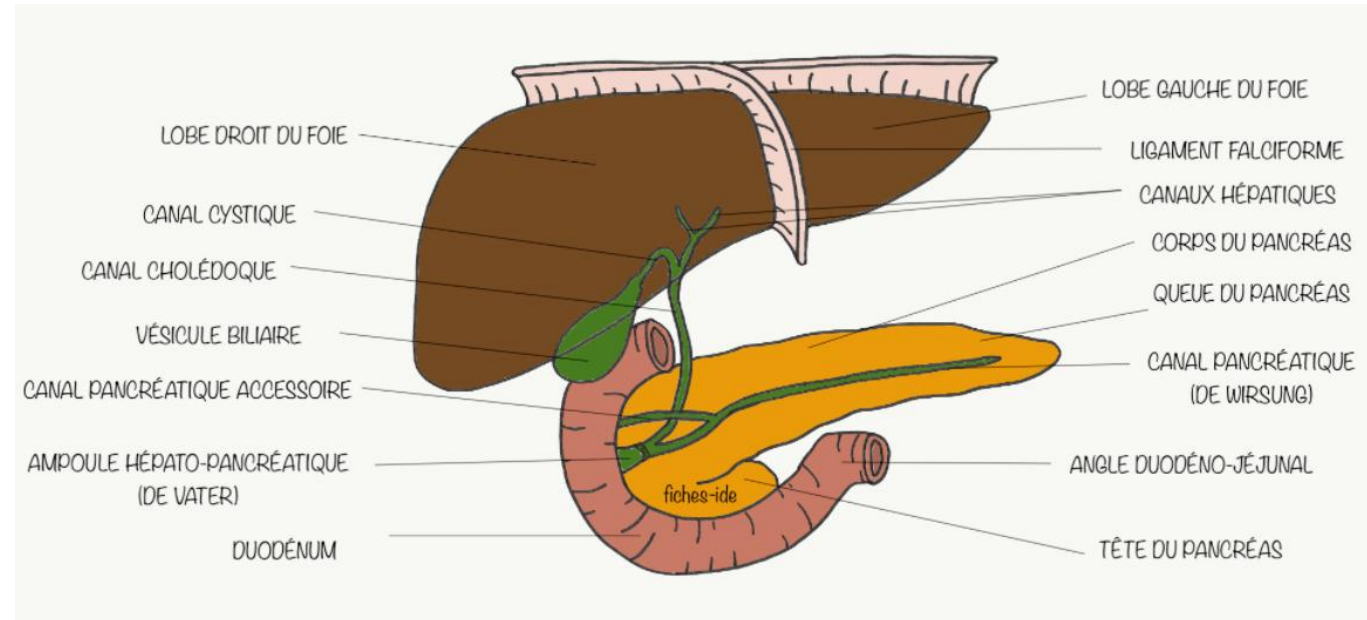
Destruction hématies usées, neutralisation de toxines & hormones, conversion de l'ammoniac

- **Stockage**

Vitamines A,D,E,K, glycogène, Fer, Cu, B12

- **Digestion**

Emulsion des graisses (production de bile)



<https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/foie-vesicule-biliaire-duodenum-et-pancreas/>

Rôle de la vésicule biliaire :

- Emmagasine et concentre la bile
- **Bile = Eau + bicarbonates + sels biliaires + lécithine + pigments biliaires**
- La bile permet la digestion des **lipides**

Définitions

pas notre domaine

	INSUFFISANCE HEPATIQUE	SURCHARGE HEPATIQUE
Définition / Symptômes	Ensemble des manifestations cliniques et biologiques dues à une diminution de la masse des cellules hépatiques. Stade modéré : asthénie, amaigrissement, sensibilité anormale aux médicaments. Stade plus avancé : ictère, somnolence, trouble de l'hémostase, troubles nerveux et endocrinien.	Ensemble des manifestations biologiques dues à une difficulté du foie à exercer sa fonction d'élimination. Acné, migraine, halitose (langue blanche, bouche pâteuse), digestion lente et difficile surtout pour les graisses (selles grasses et flottantes).
Diagnostic	Dosage des enzymes hépatiques : • Transaminases (ASAT et ALAT) • Gamma GT (GGT) • Phosphatases alcalines (PAL) Dosage de la bilirubine (pigment biliaire) Ces valeurs augmentent lors de la destruction des cellules hépatiques.	La surcharge hépatique ne s'accompagne d'aucunes lésions et n'est pas répertoriée comme une pathologie par l'allopathie. N'est pas détectable par des analyses biologiques.

Insuffisance hépatique

*pas notre
domaine*

- **Causes possibles**



HEPATITE

CIRRHOSE

INSUFFISANCE
HEPATIQUE

TUMEUR
DETRUISANT LE
FOIE

Virale, toxique, médicamenteuse

Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Traiter l'hépatite si elle est à l'origine de l'insuffisance hépatique

- Il n'y a pas de médicament pour remplacer la fonction hépatique.
- Seule la **greffe du foie**, quand elle est possible, peut guérir le consultant.

En naturopathie

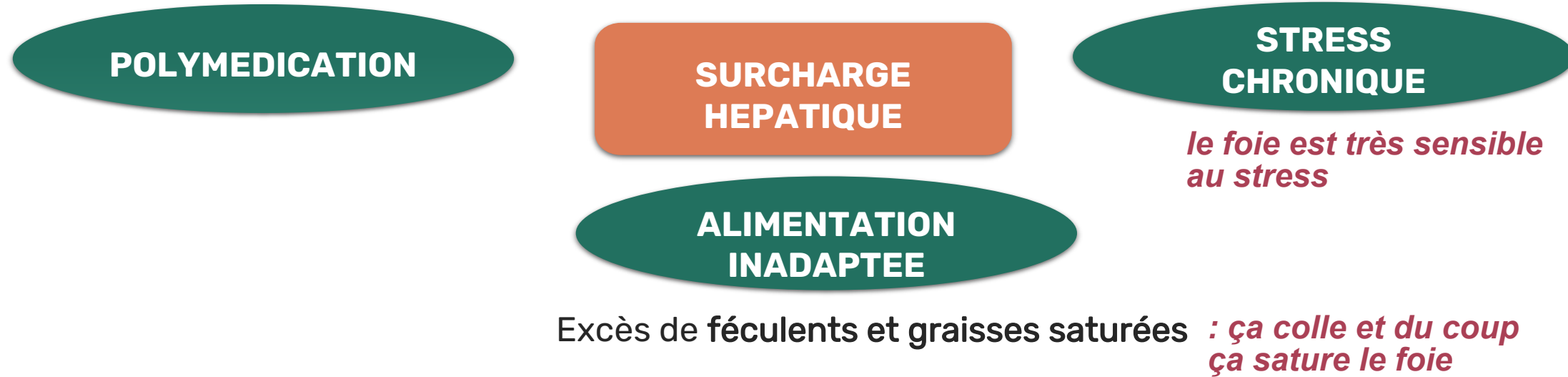


- **Aucun accompagnement possible. Réservé à l'allopathie**



Surcharge hépatique

- **Causes possibles**



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « *Vos selles sont-elles grasses ?* »
- « *Avez-vous des migraines ?* »
- « *Avez-vous la langue blanche et pâteuse ou mauvaise haleine ?* »
- « *Votre peau est-elle grasse, acnéique ?* »

- **Ce que l'on propose :**

En allopathie



Pas de traitement car n'est pas considéré comme une pathologie par l'allopathie.

Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

OBJECTIF : Stimuler la fonction hépatobiliaire pour favoriser l'élimination des toxines



Alimentation bénéfique pour le foie : légumes à feuilles vertes, **crucifères**, **navet**, **romarin**, **citron**, **curcuma**, radis noir, ...

Bouillote ou bain chaud sur le foie après le repas

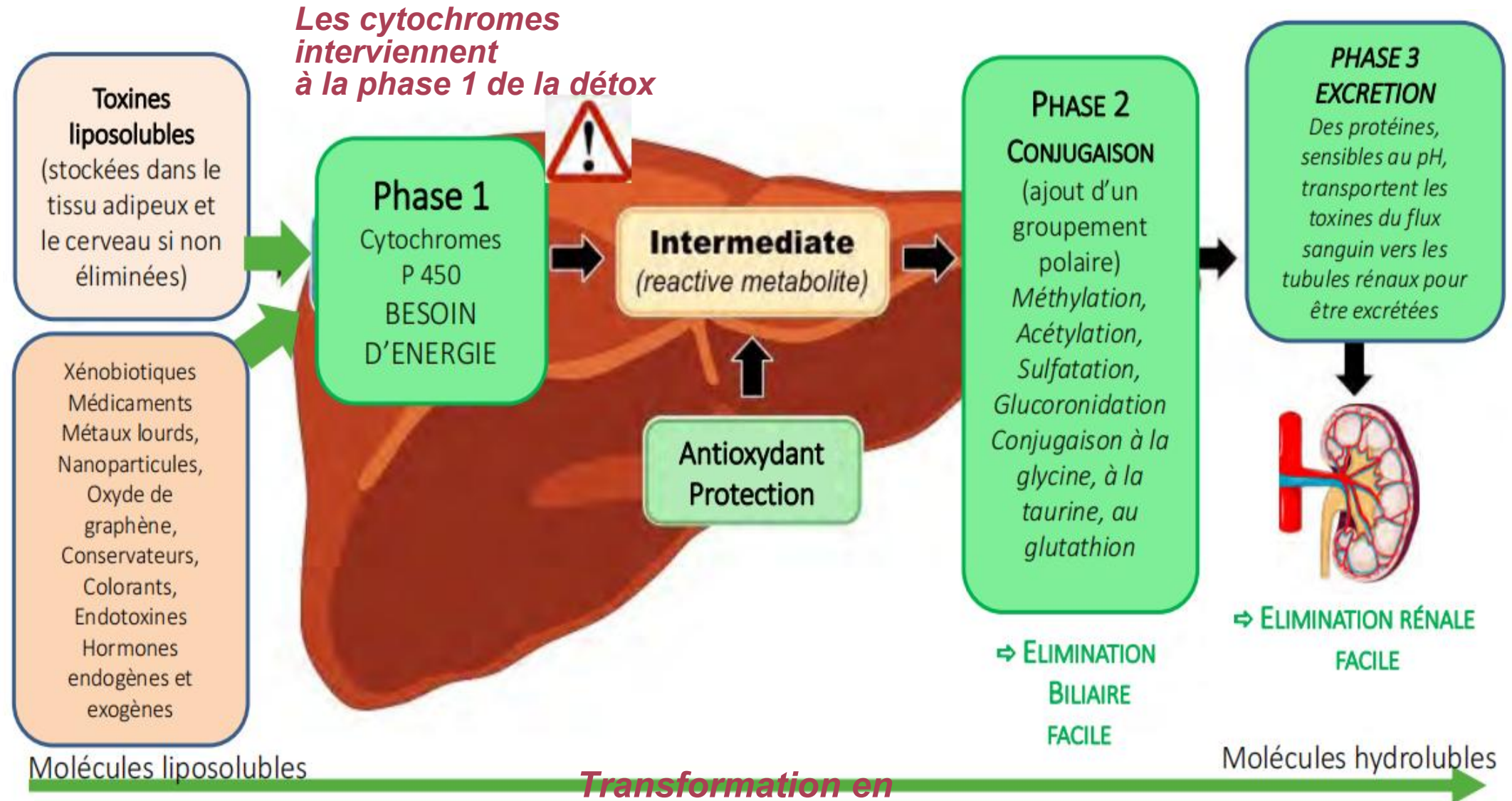
Techniques de relaxation

Phytothérapie (plantes cholagogues et cholérétiques) : Chardon-marie, artichaut, fumeterre, boldo, radis noir, ...

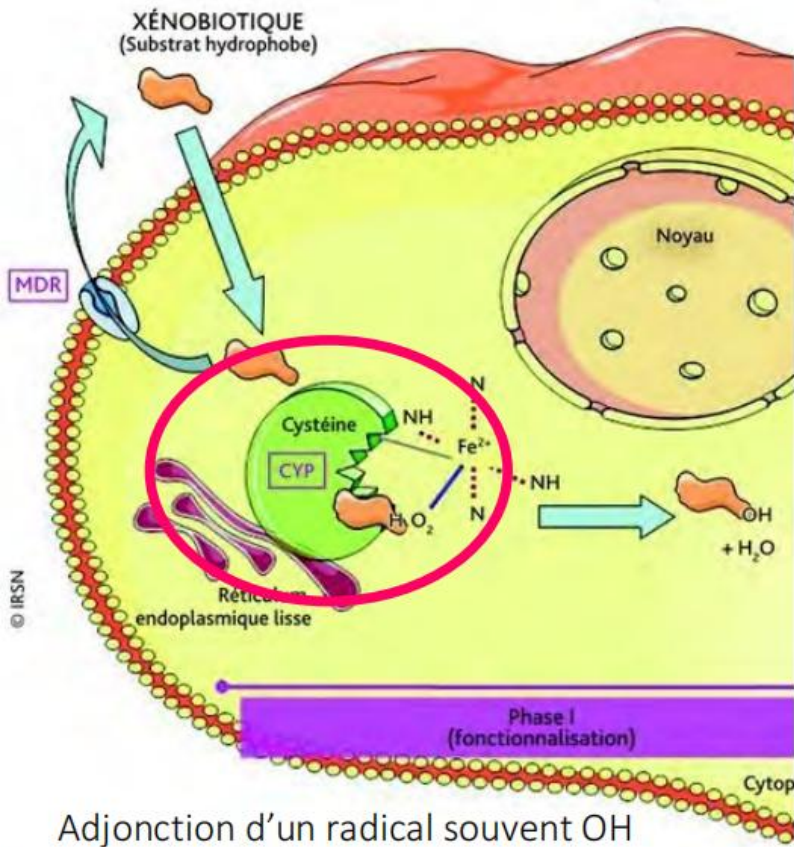
Aromathérapie voie orale suite à un traitement médicamenteux lourd : Livèche, carotte, romarin à verbénone, Lédon du Groenland, citron ***A voir car si l'on donne des HE il va y avoir encore plus à éliminer***

Rappels sur la détoxification hépatique

il faut en principe donner des plantes pour la phase 1 et 2 pour ne pas se retrouver ds l'intermédiaire avec des métabolites toxiques pour le foie si plantes qu'en phase 1



Médicaments et plantes hépatiques



Les médicaments ne sont pas tous métabolisés de la même façon par le foie. Ce sont les **cytochromes** et plus précisément les **isoenzymes des cytochromes P450** qui vont les **éliminer** plus ou moins rapidement. Certaines **substances** vont **induire ou inhiber ces isoenzymes**.

Les substances **inductrices** = substances qui **accélèrent l'élimination** du médicament (ou substrat) → diminution de l'efficacité de celui-ci.

Les substances **inhibitrices** = **ralentissement de l'élimination** du médicament → risques (toxicité).

Donc attention si la personne prend des médicaments !!

	CYP1A2	CYP2C9*	CYP2D6*	CYP3A4
SUBSTRAT	théophylline caféine	Phénytoïne Diclofenac Warfarine	codéine captopril imipramine fluoxétine metoprolol	ciclosporine tacrolimus ketoconazole midazolam statine
INHIBITEUR	cimétidine quinolones fluvoxamine  CHARDON MARIE  SFN	Isoniazide ritonavir  CURCUMA	quinidine fluoxétine  CHARDON MARIE  CURCUMA	macrolides naringenine (jus pamplemousse) Antifongiques azolés Antiprotéases  CHARDON MARIE  CURCUMA  SFN
INDUCTEUR	rifampicine omeprazole cigarette  RÉGLISSE	rifampicine	  FUMETERRE	carbamazépine phénytoïne phénobarbital Millepertuis (tisanes...)  MILLEPERTUIS

Avant de préconiser la plante, il faut **connaître la voie métabolique d'élimination** du médicament, soit **l'isoenzyme du cytochrome P450** qui est **active** pour ce médicament.

Ensuite, il faut regarder les **plantes inhibitrices ou inductrices** de l'isoenzyme et ne **pas les préconiser** car risque que le **médicament ne soit plus efficace** ou risque qu'il **devienne toxique ou dangereux**.

Ex : **Alprazolam**
(CY3A4/5) + Millepertuis
(inducteur puissant du CY3A4/5) → diminution de l'efficacité de l'Aloprazolam

Cholestase, cytolyse

- Données biologiques

Cholestase : Réduction ou arrêt du flux biliaire

Cytolyse hépatique : Destruction des cellules

Paramètres	Cholestase	Cytolyse
Albumine	N (<i>Neutre</i>)	N
Bilirubine	N ou augmenté	N ou augmenté
Cholestérol	Augmenté	N
Fer	N	Augmenté
Gamma GT	Augmenté	N ou augmenté
LDH	N	Augmenté
Phosphatases alcalines	N ou augmenté	N ou augmenté
Transaminases	N ou augmenté	Augmenté +++
TP	Bas avec un facteur V normal	N
Vit A, D, E, K	Bas	N

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES, CYTOCHROMES P450 ET P-GLYCOPROTEINE (Pgp)

	1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	PgP		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	PgP		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	PgP	
acénocoumarol										étoposide											paclitaxel									
acide méfénamique										étravirine											pantoprazole									
acide valproïque										felbamate											paracétamol									
agomelatine										félopidine											paroxétine									
alfentanil										fentanyl											phénobarbital									
alprazolam										fexofénadine											phenprocoumone									
amiodarone										finastéride											phénytoïne									
amitriptyline										flécaïnone											pioglitazone									
amlodipine										fluoxétine											piroxicam									
apixaban										flurbiprofène											prasugrel									
aripiprazole										fluvastatine											prednisolone									
artéméthér										fluvoxamine											proguanil									
atazanavir										fosamprénavir											prométhazine									
atomoxétine										galantamine											propafénone									
atorvastatine										géfinitib											propofol									
bisoprolol										gestodène											propranolol									
bortézomib										glibenclamide											quétiapine									
bosentan										glicazide											quinidine									
bromocriptine										glimépiride											quinine									
buprénorphine										granisétron											ranitidine									
bupropion										halopéridol											rabéprazole									
caféine										hydrocodone											réboxétine									
cannabidiol										ibuprofène											répaglinide									
carbamazépine										ifosfamide											rifabutine									
carvédilol										imatinib											rilpivirine									
célécoxib										imipramine											rispéridone									
celiprolol										indinavir											ritonavir									
chlorphéniramine										irbésartan											rivaroxaban									
ciclosporine										isradipine											saquinavir									
citalopram										itraconazole											saxagliptine									
clarithromycine										kétoconazole											sertraline									
clobazam										lansoprazole											sildénafil									
clomipramine										letrozole											simvastatine									
clonazépam										lévomépromazine											sirolimus									
clopidogrel										lidocaïne											sorafénib									
clozapine										lopéramide											sufentanil									
cobisistat										lopinavir											sulfaméthoxazole									
codéine										loratadine											sunitinib									
colchicine										losartan											tacrolimus									
cortisol										luméfántrine											tadalafil									
cyclophosphamide										maprotiline											tamoxifène									
dabigatran										maraviroc											tamsulosine									
darunavir										médroxyprogestérone											ténoxycam									
dasatinib										méfloquine											terbinafine									
delavirdine										méloxycam											terféndine									
désogestrel										méthadone											testostérone									
dexaméthasone										méthylprednisolone											THC									
dextrométhorphane										metoclopramide											théophylline									
diazépam										métoprolol											ticagrelor									
diclofénac										miansérine											timolol									
dienogest										midazolam											tizanidine									
digoxine										mifépristone (RU486)											tolbutamide									
dihydrocodéine										mirtazapine											toltérodine									
dihydroergotamine										moclobémide											torasémide									
diltiazem										modafinil											tramadol									
diphénhydramine										montélukast											trazodone									
docétaxel										naproxène											triazolam									
dolutegravir										natéglidine											trimipramine									
donépézil										nébivolol											tipranavir (avec ritonavir)									
dronédarone										nelfinavir											tropisetron									
duloxétine										névirapine											vardénafil									
dutastéride										nifédipine											venlafaxine									
ecstasy (MDMA)										nilotinib											vérapamil									
efavirenz										nimodipine											vinblastine									
elvitravir										nitrendipine											vincristine									
ergotamine										noréthistérone											voriconazole									
erlotinib										nortriptyline											warfarine									
érythromycine										olanzapine											zafirlukast									
ésoméprazole										oméprazole											zolmitriptan									
éthanol										ondansétron											zopiclone									
éthinyloestradiol										oxybutyline											zuclopenthixol									
éthosuximide										oxycodone																				
voie conduisant à un métabolite actif										voie métabolique majeure											voie métabolique mineure									

voie conduisant à un métabolite actif



voie métabolique majeure



voie métabolique mineure



Tableau 1 : Substrats des cytochromes P450 et de la Pgp

	1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp	
acide valproïque										erythromycine											néfazodone									
amiodarone										ésoméprazole											nelfinavir									
ananas										éthinyloestradiol											nifédipine									
atazanavir										étravirine											nilotinib									
bortézomib										felbamate											nitrendipine									
bupropion										flécaïnone											norfloxacine									
cannabidiol										fluconazole											oméprazole									
célécoxib										fluoxétine											pantoprazole									
chardon marie (silibinine)										fluvastatine											paroxétine									
chloroquine										fluvoxamine											prasugrel									
chlorpromazine										fosamprénavir											prométhazine									
ciclosporine										géfinitib											propafénone									
cimétidine										gemfibrozil											quétiapine									
ciprofloxacine										gestodène											quinidine									
citalopram										grapefruit, orange de Séville											réboxétine									
clarithromycine										halopéridol											régisse									
clomipramine										imatinib											rilpivirine									
clopidogrel										indinavir											rispéridone									
cobisistat										irbésartan											ritonavir									
curcuma										isoniazide											roxithromycine									
darunavir										itraconazole											saquinavir									
dasatinib										kétoconazole											sertraline									
delavirdine										lansoprazole											simvastatine									
désogestrel										lévomépromazine											sorafénib									
dihydralazine										lopinavir											sulphamethoxazole									
diltiazem										losartan											terbinafine									
diphényhydramine										luméfautrine											tipranavir (avec ritonavir)									
dipyridamole										méthadone											topiramate									
disulfirame										métoclopramide											triméthoprim									
doxycycline										métronidazole											venlafaxine									
dronédarone										miconazole											vérapamil									
duloxétine										moclobémide											vinblastine									
efavirenz										modafinil											voriconazole									
erlotinib										natéglidine											zafirlukast									

<

Tableau 2. Inhibiteurs des cytochromes P450 et de la Pgp

inhibiteur puissant

inhibiteur modéré

	1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp		1A2	2B6	2C8	2C9	2C19	2D6	2E1	3A4/5	Pgp	
bosentan										isoniazide											phénobarbital									
carbamazépine										lansoprazole											phénytoïne									
cyclophosphamide										légumes (chou, brocoli)											primidone									
dexaméthasone										méprobamate											rifabutine									
efavirenz										métamizole											rifampicine									
elvitravir										millepertuis											ritonavir									
éthanol										modafinil											tabac (goudrons)									
étravirine										névirapine											topiramate									
felbamate										oméprazole																				
ifosfamide										oxcarbazépine																				

Tableau 3. Inducteurs des cytochromes P450 et de la Pgp

inducteur puissant

inducteur modéré

Tableau 3. Inducteurs des cytochromes P450 et de la Pgp

inducteur puissant

inducteur modéré

Inhibition

Cytochromes : L'impact dépend de : **a)** l'importance relative de la voie d'élimination inhibée par rapport à la clairance totale; **b)** présence ou non de métabolites actifs et **c)** concentrations d'inhibiteur. A l'arrêt du traitement inhibiteur, l'activité du CYP retourne progressivement à la normale (4 demi-vies). *Exemples* : l'amiodarone inhibe fortement l'activité du CYP2C9; associée à l'acénocoumarol, substrat du CYP2C9, elle en ralentira l'élimination, d'où un risque d'hémorragie justifiant une adaptation posologique et un suivi INR rapproché. La **fluoxétine** inhibe fortement l'activité du CYP2D6; associée à la **codéine**, elle peut en abolir l'efficacité (! signifie que la codéine génère un métabolite actif, la morphine).

P-glycoprotéine : L'impact dépend de l'affinité du substrat pour ce transporteur, de la concentration et de la puissance de l'inhibiteur. Comme pour les CYP, l'activité de la Pgp retourne progressivement à la normale à l'arrêt du traitement inhibiteur (4 demi-vies). *Exemple* : la **ciclosporine** inhibe fortement l'activité de la Pgp. Associée à l'**indinavir**, substrat de la Pgp, elle entraînera une augmentation de sa biodisponibilité.

Induction

Cytochromes : L'impact dépend de : **a)** importance relative de la voie d'élimination induite par rapport à la clairance totale; **b)** présence ou non de métabolites actifs et **c)** concentrations d'inducteur. A l'arrêt du traitement inducteur, l'activité du CYP retourne progressivement à la normale (>2 semaines après disparition de l'inducteur dans le sang). *Exemple* : Le **millepertuis** induit progressivement et puissamment l'activité du CYP3A4. Il accélérera fortement l'élimination de l'**éthinyloestradiol**, substrat majeur du CYP3A4, et l'effet contraceptif ne sera plus assuré; il faudra donc prévoir un autre mode de contraception.

P-glycoprotéine : L'impact dépend de l'affinité du substrat pour ce transporteur, de la concentration et la puissance de l'inducteur. Comme pour les CYP, l'activité de la Pgp retourne progressivement à la normale à l'arrêt du traitement inducteur (>2 semaines après disparition de l'inducteur dans le sang). *Exemple* : la **rifampicine** induit fortement l'activité de la Pgp. Associée au **rivaroxaban**, substrat de la Pgp, elle entraînera une diminution de sa biodisponibilité.

Des tableaux dynamiques régulièrement mis à jour et comprenant davantage de molécules sont accessibles sur le site www.pharmacoclin.ch, rubrique Centre d'informations thérapeutiques et de pharmacovigilance > outils > carte dynamique des interactions médicamenteuses et CYP

Centre d'informations thérapeutique et de pharmacovigilance

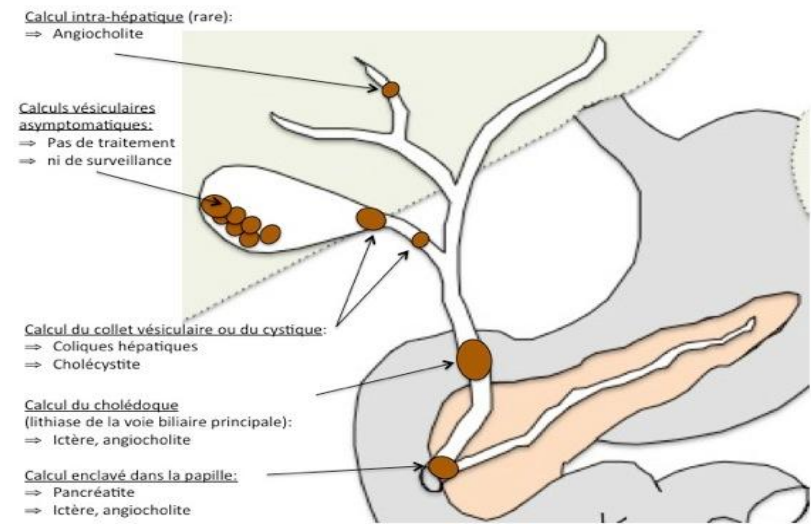
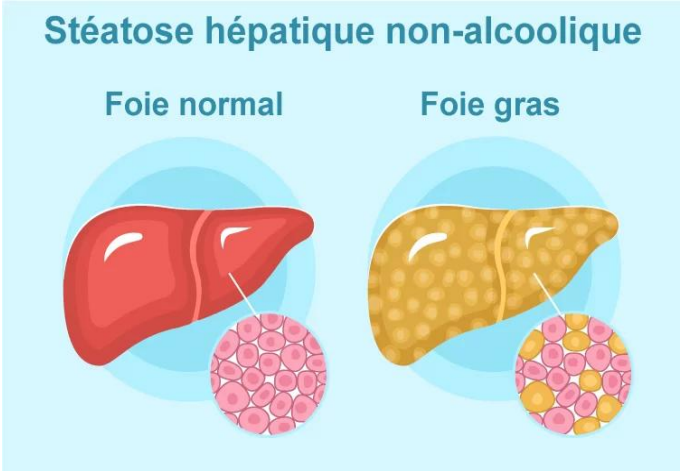
Service de pharmacologie et toxicologie cliniques, Hôpitaux Universitaires, 1211 Genève 14

Tél. 022 372 99 32 - Fax 022 372 99 45 - www.pharmacoclin.ch - Copyright SPTC - Genève, Octobre 2014

2. NASH ou NAFLD

Définitions

	NASH ou NAFLD (Stéatose hépatique)	LITHIASES BILIAIRES
Définition / Symptômes	NASH = Stéato Hépatite Non Alcoolique NAFLD = Non Alcoholic Fatty Liver Disease <i>(in english)</i> Accumulation de graisse dans les cellules du foie.	Calculs qui se forment dans la vésicule biliaire et qui peuvent migrer dans les voies excrétrices biliaires. Asymptomatique le plus souvent. Parfois, douleurs sous les côtes en haut et à droite de l'abdomen. Se diagnostique par échographie.



- Facteurs favorisants

Albumine : **Bas**

HDL : **Bas**

Triglycérides : **Très haut +++**

Première cause d'élévation des transaminases chez l'obèse.

Echographie permettant de constater un foie avec un volume important.

- Ce que l'on propose :

En allopathie



OBJECTIF

Agir sur les causes du syndrome métabolique

Traitement et accompagnement adapté à chaque situation (cf. cours pathos cardio-vasculaires + Conseils hygiéno-diététiques) **sera abordé en cours avec Pascale F**

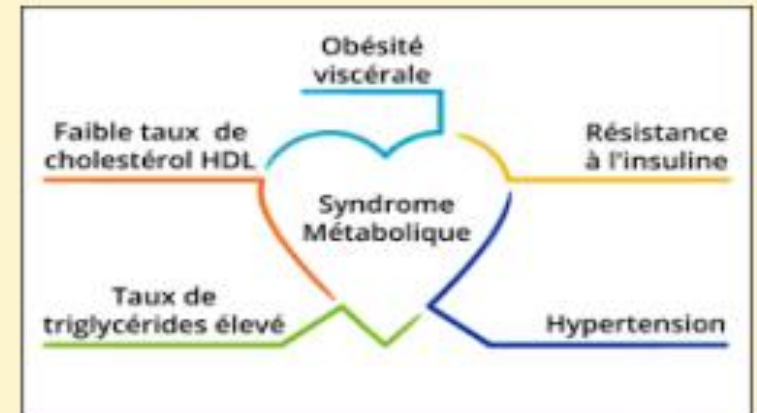
DIABETE DE
TYPE 2

OBESITE

NASH

HYPERLIPIDEMIE

En naturopathie



**Syndrome métabolique
3 de ces 5 facteurs**

Source : <http://www.syndromedelabedaine.org>

Glycémie à jeun
 ≥ 1 g/litre

Triglycéridémie à jeun
 $\geq 1,5$ g/litre

Tour de taille
Hommes : ≥ 102 cm
Femme : ≥ 88 cm

HDL cholestérol à jeun
< normale
Hommes < 0,4 g/litre
Femmes < 0,5 g/litre

Pression artérielle
Systolique > 130 mm Hg
ou
Diastolique ≥ 85 mm Hg

Phytothérapie appliquée

le plus gros travail se fera avec l'hygiène de vie !

Choleretique : Stimule la production de bile par le foie

Cholagogue : Facilite l'évacuation de la bile

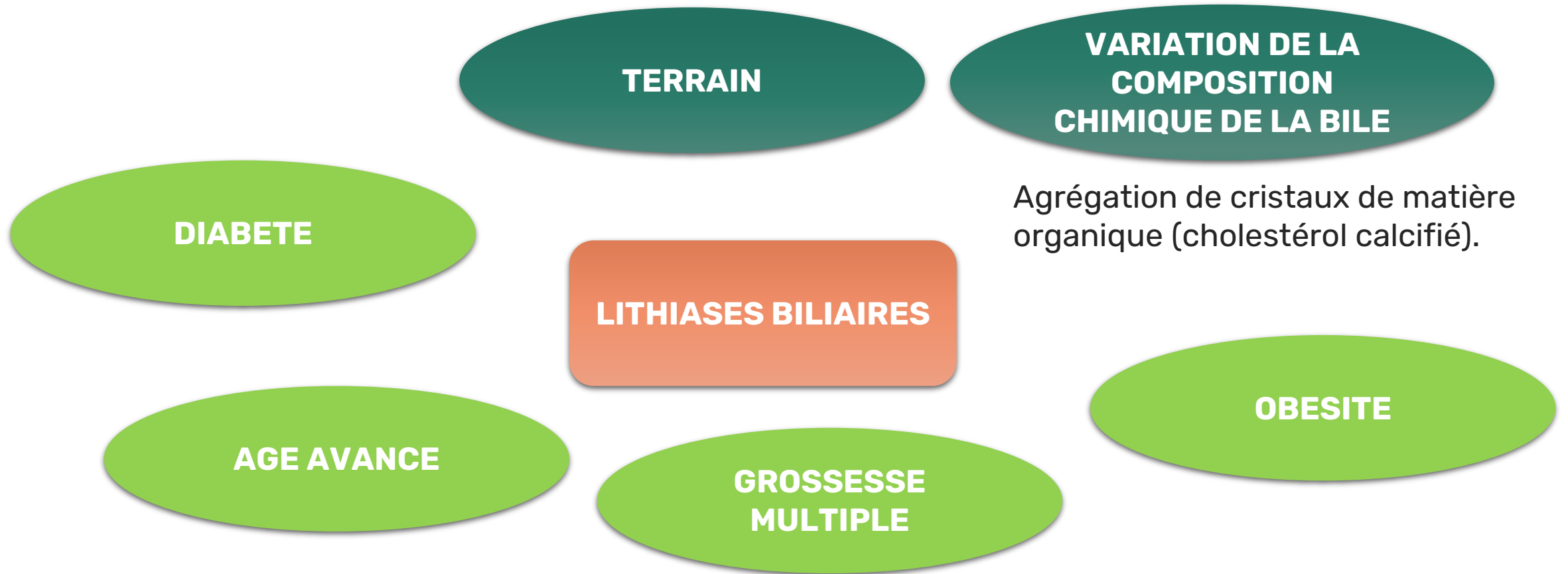
Se servir du tableau des interactions médocs et plantes ci-dessus pr voir les possibilités

Substrats	CHOLÉRÉTIQUE	CHOLAGOGUE	PHASE I	PHASE II	HÉPATO PROTECTEUR	NASH
ARTICHAUT	amphocholérétique	++	+	++	++	
CHARDON MARIE	++	++	--	++	++	+++
CHLORELLA			--	++		
CURCUMA	++	+	--	+++	+++	+++
DESMODIUM			?	+	+++	++
FUMETERRE	amphocholérétique	++	++	?		
LIN			?	+++		
MILLEPERTUIS	+		+++	?	+	
RADIS NOIR	++	++	--	+++		
RÉGLISSE			+	++	+++	+++
ROMARIN	+	+	+	++	++	++
ROMARIN JEUNE POUSSE	+++	+++	+	++	+++	+++
GENEVRIER JEUNE POUSSE	++	++	--	+++	++	++
CHRYSANTELLUM AMERICANUM				+	++	++
SCHISANDRA			++	+		++++

Suite du tableau

3. Lithiases biliaires

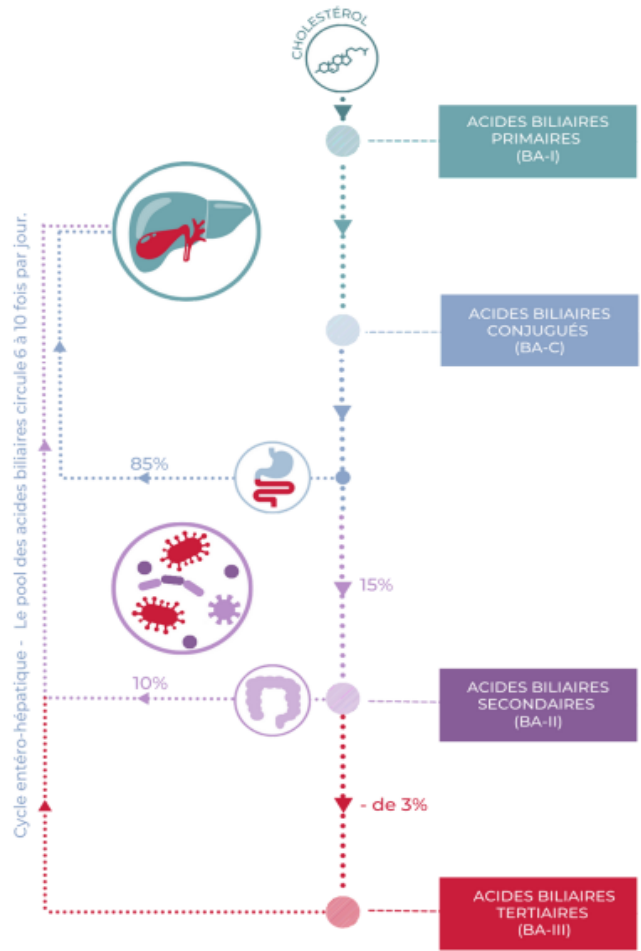
- Causes et facteurs aggravants



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Y-a-t-il des calculs biliaires dans votre famille? »
- « Avez-vous encore votre vésicule biliaire? »
- « Quel est votre taux de cholestérol? »
- « Vos selles sont-elles grasses ? »

Analyses sur les acides biliaires :



ACIDES BILIAIRES PRIMAIRES					
CA	Acide cholique	0.01	μmol/L	0.01 - 0.4	
CDCA	Acide chénodésoxycholique ↘	0.008	μmol/L	0.017 - 0.45	
ACIDES BILIAIRES SECONDAIRES					
DCA	Acide désoxycholique	0.15	μmol/L	0.06 - 0.45	
LCA	Acide lithocholique	0.009	μmol/L	0.002 - 0.022	

ACIDES BILIAIRES CONJUGUÉS					
GCA	Acide glycocholique ↘	0.017	μmol/L	0.02 - 0.25	
AGCDC	Acide glycochénodésoxycholique ↘	0.066	μmol/L	0.15 - 1.35	
TCA	Acide taurocholique ↘	0.017	μmol/L	0.03 - 0.775	
ACIDES BILIAIRES TERTIAIRES					
UDCA	Acide ursodésoxycholique	0.013	μmol/L	0.004 - 0.085	

- Carence en fer ?
- Manque de cholestérol ?
- Dysbiose ?
- Malabsorption des vitamines ADEK ?
- Manque de L-glycine ou taurine ?
- Carence en vitamine B3 ?

Ce que l'on propose :



Enallopathie

OBJECTIF

Eviter la migration des calculs dans les voies biliaires et par conséquent une pancréatite

- En fonction de la localisation des calculs, pas de traitement ou ablation de la VB.

En naturopathie



- **Surtout ne pas préconiser de plantes hépatiques au risque de provoquer la migration des calculs dans les voies biliaires.**
- Si **ablation de la VB**, la bile n'est plus stockée et se déverse continuellement. Dans ce cas, il faut **soutenir la digestion des graisses et optimiser la qualité de la bile.**

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- **Les acides biliaires** pour évaluer la qualité de la bile

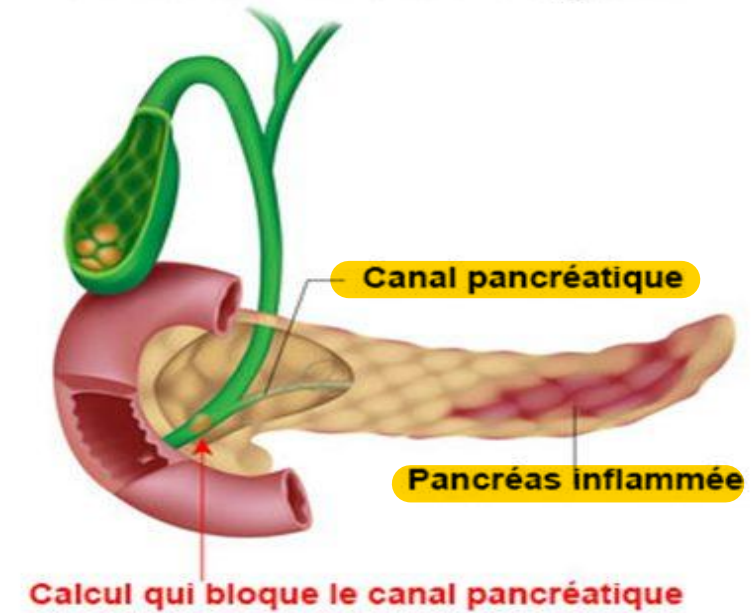
Si plus de vésicule biliaire manger les graisses en très petite quantité

V. Pathologies du pancréas

Pancréatite

PANCREATITE	
Définition / Symptômes	Inflammation aigue du pancréas (œdème et/ou nécrose) Douleur violente dans la moitié supérieure de l'abdomen
Causes	Alcoolisme Migration de calculs dans les voies biliaires
Diagnostic	Mesure des enzymes pancréatiques dans le sang (taux anormalement élevé dans le sang) + échographie et scanner

Pancréatite aiguë



Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Soulager la douleur en mettant le système digestif au repos et en luttant contre l'inflammation

- Arrêt de l'alimentation, administration d'inhibiteurs enzymatique, réhydratation, antibiotique, ablation de la VB si calculs.

En naturopathie



- Aucun accompagnement. **Réservé à l'allopathie.**

Bibliographie / webographie

Le Larousse Médical

Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy

Sans candida Albicans, Accompagner une candidose, Valérie Legros, Ed. AMYRIS

Cours «Pathologies du système digestif» Isupnat

Cours de «Phytothérapie appliquée», Isupnat

Cours «d'analyses biologiques», Isupnat

Webinaire LPEV « Maîtriser la détoxification, outil majeur d'une prise en charge holistique avec la phytothérapie et la micronutrition»

https://www.hug.ch/sites/hde/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/2002_29_4.pdf